



Introducción a la Terapia Ocupacional en Demencia y Alzheimer.

Presente.

- Clasificación de las alteraciones neurologicas
- Etiopatogenia
- intervención Terapéutica desde el enfoque Ocupacional
- Actividad Ocupacional

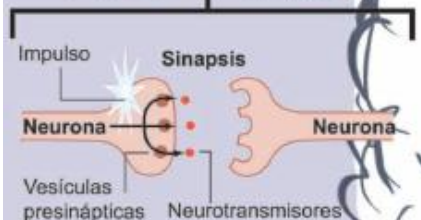
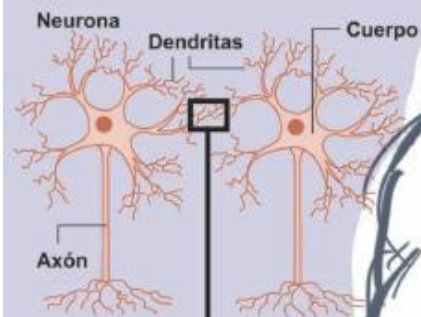
El Alzheimer

Se trata de una enfermedad degenerativa que provoca una pérdida de neuronas en las áreas esenciales para el recuerdo y el razonamiento

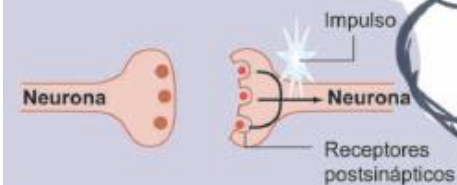
CEREBRO SANO

Las neuronas son las células principales del sistema nervioso

Los procesos del sistema nervioso consisten en la transmisión de pequeños impulsos eléctricos por filamentos (dendritas y axiones)



1 El impulso eléctrico estimula la neurona y ésta libera varios compuestos químicos (neurotransmisores) en la sinapsis (espacio entre ella y otra neurona)



2 La neurona adyacente recibe esos neurotransmisores y reproduce el impulso eléctrico y así sucesivamente

Corteza cerebral

Cerebelo

Hipocampo

El volumen del cerebro se reduce

Ventriculos aumentados severamente

Severo encogimiento del hipocampo

CEREBRO ENFERMO

La enfermedad es provocada por una disfunción en el procesamiento de ciertas proteínas sin que se conozca la causa

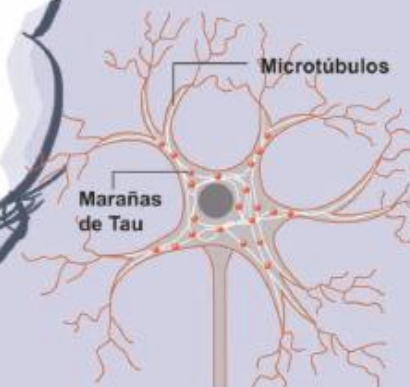
Proteína beta-amiloide



Se presenta una gran concentración de la proteína beta-amiloide en los espacios entre las neuronas. Esta acumulación provoca placas seniles que obstruyen el desarrollo normal de la actividad nerviosa y mata a las neuronas

Microtúbulos

Marañas de Tau



Dentro de la neurona, los microtúbulos dan soporte y vías para los nutrientes. Se produce una acumulación anormal de la proteína Tau, que se acopla a los microtúbulos, los altera y acaba con la neurona

LA DEMENCIA

DEFINICION

La demencia es una condición adquirida y crónica, caracterizada por un deterioro de diversas funciones cerebrales, sin distinción de sexo y situación socioeconómica, se acompaña de síntomas cognitivos, psicológicos y cambios conductuales.

Factores de riesgo para demencias



Factores modificables



Factores no modificables





DIFERENCIAS ENTRE DEMENCIA Y ALZHEIMER

DEMENCIA

- No es una enfermedad.
- Es un conjunto de síntomas y signos.
- Está provocada por una enfermedad.

ALZHEIMER

- Es una enfermedad.
- Provoca demencia.

¿Sabías que el término demencia senil no existe?

Este término es mal utilizado para referirse a una amplia gama de síntomas, sin embargo, no existe una enfermedad llamada así.

El adjetivo "senil" se usaba antiguamente debido a que la mayoría de los afectados desarrolla demencia en la vejez, después de los 65 años, con lo cual la demencia se veía como una parte inevitable del envejecimiento.

El uso del término "demencia senil" generaliza y estereotipa una condición muy diversa que tiene muchas causas.



Existen distintos tipos de demencias, como la causada por la enfermedad de Alzheimer. También existe la demencia vascular, o la demencia por cuerpos de Lewy, entre algunas otras. Pero al decir "demencia senil" se entiende que se trata de algo característico de la vejez, lo cual no es verdad pues no todas las demencias ocurren en personas mayores de 60 años, y tampoco todas las personas mayores desarrollan demencia en algún momento.

**Lo correcto
es decir sólo
demencia.**



- intervención Terapéutica desde el enfoque Ocupacional
- La terapia ocupacional (TO) es una profesión del área de la salud que busca promover el bienestar y mejores niveles de salud por medio de la ocupación. Como modalidad de apoyo no farmacológico, la TO suele estar presente en las recomendaciones de experto para el abordaje de las demencias, con el propósito primario de promover la participación de las PcDem en actividades de la vida diaria como estrategia de ajuste para la persona y su entorno. Los terapeutas ocupacionales trabajan con las personas y las comunidades para optimizar su capacidad de involucrarse en las ocupaciones que quieran, que necesiten, o que se espera que se realicen, a través de la modificación de la ocupación misma o del ambiente, para apoyar así su participación.

¿Cómo aporta la terapia ocupacional en el tratamiento de las demencias?
How does occupational therapy contribute to dementia care?

Jean Gajardo J. y José Miguel Aravena C.
Rev. chil. neuro-psiquiatr. vol.54 no.3 Santiago set. 2016

Tabla 1. Enfoques de terapia ocupacional en demencias

	Funcional	De ajuste cotidiano
Impacto de la condición	Se centra en la pérdida de capacidades de la persona y el impacto que esto tiene en la reducción de los niveles de independencia y funcionalidad. Incorpora al ambiente social a partir de las consecuencias negativas del cuidado en las personas alrededor, usualmente desde resultados centrados en la carga del cuidador	Se centra en la calidad de vida y el ajuste adaptativo a la vida cotidiana con demencia, bajo una lógica relacional en la que el sujeto con demencia, su entorno social y su entorno físico son interdependientes y por ende, el ajuste se da a partir de las condiciones de los tres componentes en las situaciones cotidianas que pueden ser desafiantes para la persona y su entorno
Propósitos	Busca la optimización de capacidades físicas y cognitivas individuales para la mantención del desempeño individual en actividades de la vida diaria	Busca modular el impacto que los síntomas cognitivos, psicológicos y conductuales pueden tener en la participación del sujeto y su relación con el ambiente cotidiano
Evaluación	Utiliza instrumentos de evaluación centrados en el sujeto con demencia y la medición de sus capacidades (cognitivas, físicas) o niveles de independencia o riesgo	Utiliza instrumentos de evaluación para diversos resultados tanto en la persona con demencia como su entorno: calidad de vida, síntomas neuropsiquiátricos y su impacto, conocimiento de capacidades, autoeficacia, interacción social, formas de comunicación, entre otros
Modalidades de intervención	Basa su acción en la estimulación y entrenamiento de habilidades, la prescripción de actividades ejecutables para desarrollar por el sujeto, la modificación del ambiente físico para la reducción de potenciales riesgos físicos, y busca reducir la carga en cuidadores a través de acciones generalmente grupales y la regulación de las rutinas de cuidado	Se centra en la promoción de la participación de la persona con demencia en situaciones y actividades cotidianas, enfatizando en la interrelación con otras personas y el ambiente físico, incorporando acciones personalizadas, privilegiando intervenciones individuales y considerando elementos biográficos en la modificación del ambiente, la adaptación de actividades y la capacitación al entorno de apoyo

¿Cómo aporta la terapia ocupacional en el tratamiento de las demencias?

How does occupational therapy contribute to dementia care?

Jean Gajardo J. y José Miguel Aravena C.

Rev. chil. neuro-psiquiatr. vol.54 no.3 Santiago set. 2016

- La participación en actividades cotidianas se ha descrito como un punto de encuentro entre la PcDem y su cuidador familiar y es con frecuencia el escenario de interés para la terapia ocupacional con el propósito de favorecer experiencias positivas de involucramiento en actividades para la persona y su entorno social. Los cuidadores familiares manifiestan con frecuencia observar que sus familiares con demencia carecen de la motivación y agencia por participar en actividades.

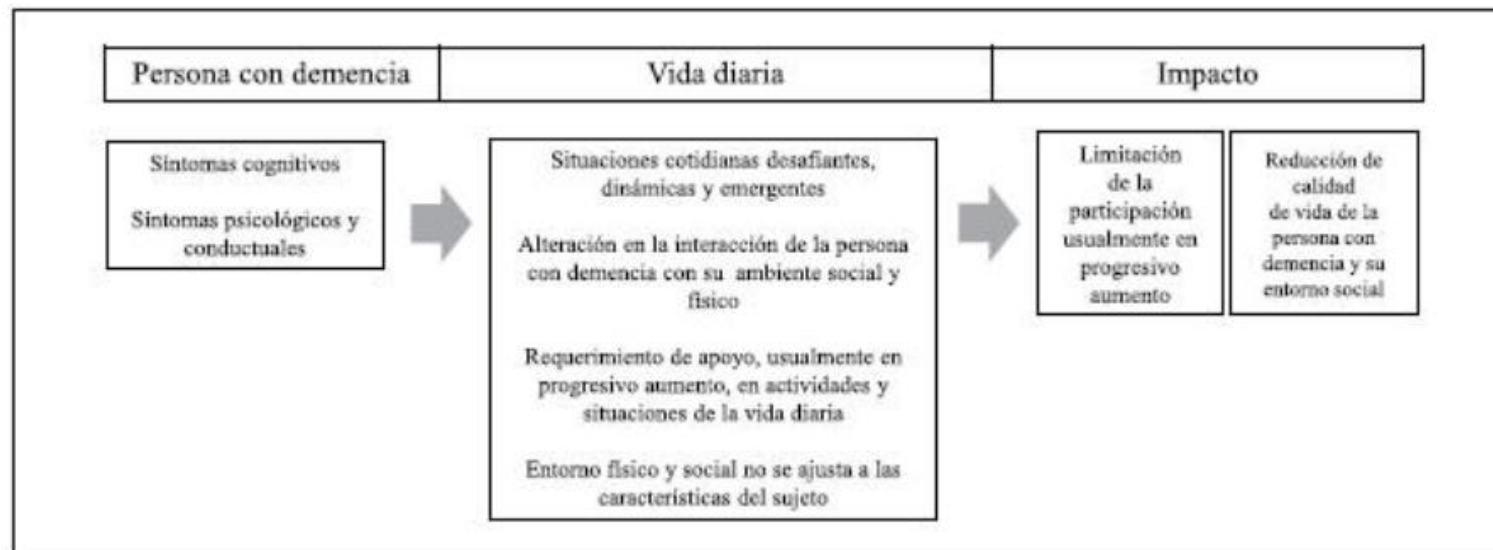


Figura 1. Relación teórica entre síntomas de la demencia, participación y calidad de vida.

Tabla 2. Intervenciones de terapia ocupacional en demencia y sus potenciales resultados

Autor	Año	País	Tipo de estudio	Intervención	Potenciales resultados
Kumar P, et al ²⁴	2014	India	ECA	- 10 sesiones de TO (70 min cada sesión) durante 5 semanas - Cada sesión de intervención dirigida a la PcDem basada en: ejercicios de relajación, ejercicio físico, realización de actividades de la vida diaria, estimulación cognitiva, actividades recreativas	- Mejora calidad de vida de la PcDem (dominios psicológicos y de salud física)
Ferrero-Arias J, et al ²⁵	2011	España	ECA	- 4 semanas de intervención grupal (20 sesiones) en una residencia - Cada sesión tenía una duración de 50 min y se dividió por temática según día: Día 1: Música Día 2: Arte Día 3: Actividad psicomotora y mímica Repetición de ciclo	- Reducción de la apatía en la PcDem
Gitlin L, et al ²⁶	2010	Estados Unidos	CE ECA	- 8 sesiones de TO (6 en casa, 2 por teléfono) con programa de actividades personalizadas (4 meses) - Actividades diseñadas a la medida (historia, contexto, intereses), modificación de estilos de comunicación del cuidador, y modificaciones ambientales	- Reducción en el tiempo en tareas de cuidado del cuidador
Gitlin L, et al ²⁷	2010	Estados Unidos	ECA	- 12 sesiones: 10 sesiones de TO, 1 sesión enfermería, 1 contacto telefónico - Intervención basada en objetivos personalizados en relación a necesidades de la PcDem, el cuidador, y su interacción con el ambiente bajo una aproximación de resolución de problemas y satisfacción de necesidades no cubiertas	- Aumenta funcionalidad de la PcDem - Aumenta participación de la PcDem - Aumenta bienestar de cuidador - Aumenta confianza del cuidador en el diseño de actividades para la PcDem

¿Cómo aporta la terapia ocupacional en el tratamiento de las demencias?
How does occupational therapy contribute to dementia care?

Jean Gajardo J. y José Miguel Aravena C.
Rev. chil. neuro-psiquiatr. vol.54 no.3 Santiago set. 2016

Autor	Año	País	Tipo de estudio	Intervención	Potenciales resultados
Graff MJ, et al ³⁰	2008	Holanda	CE ECA	- 10 sesiones TO 1 h (5 semanas) - Reconocimiento de problemas (COPM, OPHI-II) - Modificaciones ambientales y del estilo de cuidado - Capacitación en resolución de problemas cotidianos, SPCD, síntomas cognitivos, promoción de participación	- Costo económico de la intervención es menor al manejo habitual a 3 meses
Baldelli MV, et al ³¹	2007	Italia	PT-PT	- Intervención de TO durante 12 meses en un centro diurno para PcDem, 5 días a la semana (2 h al día) - Actividades grupales con un enfoque educacional y de interacción social (cocinar, jardinear, colorear y dibujar, actividad física)	- Reduce SPCD - Reduce prescripción de psicofármacos - Reduce uso de contención física
Graff MJ, et al ³²	2007	Holanda	ECA	- 10 sesiones TO de 1 h (5 semanas) - Reconocimiento de problemas (COPM, OPHI-II) - Modificaciones ambientales y del estilo de cuidado - Capacitación en resolución de problemas cotidianos, SPCD, síntomas cognitivos, promoción participación	- Mejora calidad de vida de la PcDem y cuidador - Mejora percepción de salud PcDem y cuidador - Reduce síntomas depresivos en la PcDem
Graff MJ, et al ³³	2006	Holanda	ECA	- 10 sesiones TO de 1 h (5 semanas) - Reconocimiento de problemas (COPM, OPHI-II) - Modificaciones ambientales y del estilo de cuidado - Capacitación en resolución de problemas cotidianos, SPCD, síntomas cognitivos, promoción participación	- Mejora calidad de vida de la PcDem - Mejora funcionalidad de la PcDem - Reduce sensación de carga de cuidador - Reduce costos económicos de los cuidados

Tabla 3. Potenciales resultados de la intervención de terapia ocupacional en la persona con demencia y su cuidador familiar, según tipo de intervención

Blanco de intervención	Modalidad	Intervención Estrategias específicas	Potenciales resultados	
			Cuidador	Persona con demencia
Cuidador, o Diada (persona con demencia y cuidador)	Visita domiciliaria personalizada en las necesidades y características de la persona con demencia y el cuidador	- Educación y capacitación para manejo de situaciones cotidianas desafiantes - Ajuste de actividades - Adaptación de ambiente - Cambio en estilos de cuidado - Manejo de SPCD específicos - Comprensión de la enfermedad - Actividades diseñadas a la medida, según la historia e intereses de la PcDem	- Reducción de carga percibida - Reducción de síntomas depresivos - Mejora de calidad de vida global - Aumento de autoconfianza en rol de cuidador - Reducción de costos económicos y tiempo asociado a cuidar	- Reducción de SPCD - Reducción de síntomas depresivos - Mejora participación en actividades cotidianas - Aumento de independencia en actividades - Aumento de calidad de vida
Persona con demencia	Intervención de carácter grupal en centro diurno Intervención personalizada en dispositivo atención sanitario (específico o no para demencia)	- Acciones de educación con foco en actividades diarias - Actividades de estimulación personalizadas y multicomponente (cognición, tiempo libre, físico, etc.). - Actividades estructuradas	No referidos	- Reducción de SPCD - Aumento de calidad de vida global - Reducción de contención física - Reducción de uso de psicofármacos

ESTIMULACIÓN COGNITIVA: Made with

-Técnicas: Terapia de orientación a la realidad (TOR), reminiscencia, reminiscencia musical, estimulación de las capacidades cognitivas (atención, memoria, praxis, gnosia, funciones ejecutivas).

-Objetivos: Potencializar las capacidades preservadas y compensar el deterioro, lentificando la progresión de la enfermedad con el objetivo de que la persona mantenga el contacto con la realidad y tenga la máxima funcionalidad posible. Mantener la identidad personal (20).



REHABILITACIÓN FUNCIONAL: Made with

-Técnicas: Ejercicios de movilidad funcional, para ello se trabajan varios aspectos de la psicomotricidad.

-Objetivos: Mantener las capacidades que aún posee con el objetivo de conservar el mayor grado de autonomía en su día a

REEDUCACION EN ABVD Y AIVD:

Made with

-Técnicas: Adaptación de las AVD, la reeducación de los patrones de movimiento normales o la utilización de ayudas técnicas.

-Objetivos: Mantener y/o potenciar la funcionalidad en las actividades de la vida diaria. Compensar la funcionalidad pérdida para tener un desempeño óptimo(20).



Made with

INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN:

-Técnicas: A través de ejercicios de reminiscencia o noticias actuales, donde se trabaja la fluidez y coherencia verbal, autoconocimiento emocional.





OCIO Y TIEMPO LIBRE

-Técnicas: Actividades artísticas, sociales y creativas que proporcionen el descubrimiento de nuevos intereses y que sean gratificantes.

-Objetivos: Mejorar el estado de ánimo de la persona. También se trata de fomentar intereses, manteniendo activa la participación(20).



ACOMPañAMIENTO FAMILIAR:

-Técnicas: Asesoría dirigida principalmente a proporcionar estrategias de intervención a familiares y cuidadores.

-Objetivos: Evitar sobrecargas en la familia y mejorar la rutina de cuidados(20).

- La Terapia Ocupacional es una disciplina que intenta dar solución a todas las demandas que la persona con enfermedad de Alzheimer presenta, garantizando su calidad de vida, funcionalidad, autonomía e independencia en el desempeño de las actividades de la vida diaria, aspectos clave en la intervención. La contribución del terapeuta ocupacional al cuidado de la persona que sufre una demencia se centra en la utilización y potenciación de aquellas ocupaciones que aún permanecen intactas. Las ocupaciones, base fundamental de la Terapia Ocupacional, se analizan con el fin de ajustarlas a las capacidades de las personas dentro de una rutina diaria, a sus intereses y a sus interacciones sociales. Si es necesario, también se hacen las adaptaciones necesarias del entorno para posibilitar al usuario la realización y el control de sus actividades cotidianas.

- A. BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL ALZHEÍMER
- El ejercicio físico tiene efectos beneficiosos en todas las esferas de la persona: física, psicológica y social. La mejora del sistema cardiovascular, el fortalecimiento de músculos y huesos, la mejora del equilibrio y la coordinación, la reducción del estrés y ansiedad, la mejora del estado de ánimo y del sueño o el acceso a la interacción e integración social son algunos ejemplos de estos efectos. En el usuario con alzhéimer ayuda a retrasar el deterioro producido por la enfermedad y repercute positivamente en las capacidades cognitivas. El ejercicio regular preserva la función cerebral durante más tiempo. Por estas razones, en la Terapia Ocupacional sabemos la importancia que tiene el ejercicio en los usuarios con alzhéimer, centrando las investigaciones en diferentes líneas de intervención mediante ejercicios de mantenimiento y fortalecimiento, mejorando la forma física y la independencia en las actividades de la vida diaria⁵, o mediante sesiones individuales, en las que se incluían también recomendaciones de cuidados biopsicosociales a sus cuidadores, retrasando el declive funcional y atendiendo a las necesidades de los cuidadores, respectivamente

- TRATAMIENTO
- En esta sección se especifica la intervención del terapeuta ocupacional en el abordaje del alzhéimer y otras demencias.
- Se diferencian las siguientes líneas de intervención:
- A. Estimulación de las destrezas de ejecución:
 - - Estimulación de las destrezas cognitivas (Orientación a la Realidad, Terapia de Reminiscencia, Psicoestimulación Cognitiva, ...).
 - - Estimulación de las destrezas motoras (Psicomotricidades, actividades sensoriomotores,...).
 - - Estimulación sensorial y perceptiva.
- B. Intervención a nivel funcional:
 - - Programa de AVD.
 - - Programa de higiene postural y ergonomía.
 - - Prevención de caídas.

- C. Ocio y tiempo libre:
 - - Laborterapia.
 - - Ludoterapia.
 - - Jardinería.
 - - Arteterapia.
 - - Actividades dentro de la comunidad.
- D. Otras terapias novedosas:
 - - Actividades con animales.
 - - Nuevas tecnologías.

- E. Apoyo a familias.
- - Programa ocupacional para familias.
- - Programa de asesoramiento y formación en técnicas de facilitación de AVD, productos de
- apoyo y adaptación del entorno.

Figura 1. Orientación a la Realidad. (Centro de Día Terapéutico AFAL Ferrolterra)



Figura 3 y 4. Psicomotricidad. (Centro de Día Terapéutico AFAL Ferrolterra).



Figura 5 y 6. Taller de cocina. (Centro de Día Terapéutico AFAL Ferrolterra).



Tabla 1: Beneficios de las actividades con animales. (Fuente: *La influencia de las mascotas en la vida humana*₂₀)

FÍSICA	- Mellora de la psicomotricidad fina y gruesa - Promueve la relajación - Reduce los niveles de estrés y ansiedad - Motiva las salidas al exterior y el ejercicio físico
COGNITIVA	- Estimula las principales funciones cognitivas - Mejora la atención y la concentración - Potencia el empleo de la memoria de trabajo y remota - Facilita los ejercicios de habilidades viso-espacial

Presente.